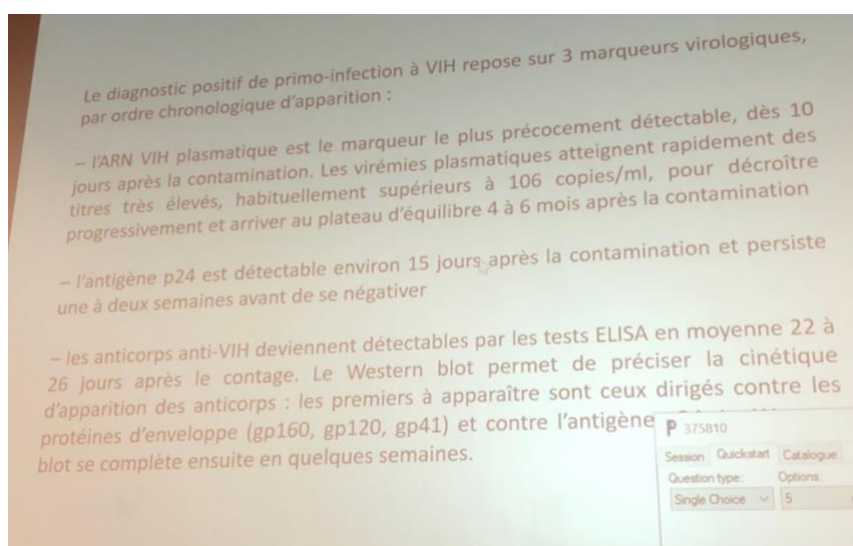


QCM de dermato

1. Photo : Quelle est la lésion élémentaire ?
 - **Papules formant une plaque annulaire** : granulome
 - Vésicules à disposition linéaire : galle, eczéma
 - Pustules en bouquet : herpès
 - Bulles formant une plaque nummulaire : n'existe pas trop
 - Nodule tumoral : c'est pas ça
2. Quels autoanticorps sont associés à des bulles ?
 - Collagène VII : ?
 - Desmoglein 1 : plutôt superficiel donc plutôt pemphigus foliacé/superficiel
 - **BP180 et 230** : pemphigoïde bulleuse (bulle sous-épidermique, PMN + éosinophiles, bande linéaire à l'immunofluorescence)
 - Ac Transglutaminase : dermatite herpétiforme
 - Ac anti-nucléaire : lupus
3. Lésions sur les mains + herpès labial
 - **Érythème polymorphe** : lésion en cocarde/en cible, 3 compartiments (centre nécrotique, tour blanc, liseré érythémateux). Histologie : nécrose épidermique centrale, épiderme intact en périph (ré-épithéliation)
 - Lichen plan : lésion polygonal lichénifié
 - Granulome annulaire
 - Mycose
4. Lésions prurigineuses et migratrices, quel traitement ?
 - **Anti-histaminiques** : contre urticaire (papule érythémateuse qui peut confluer en plaque, oedémateuse → oedème dermique en raison de la dilatation des vx + éosinophiles et neutrophiles)
 - Corticoides PO : dépend du stade et de la sévérité de la maladie
 - Corticoides topiques ne marche pas car cible l'inflammation, ici la cause princ c'est l'œdème, y a pas beaucoup de cell inflammatoires
 - Rétinoïdes indication : acné, eczéma des mains résistant aux ttt corti topique
 - Inhibiteur de calcineurine : eczéma
 - Immunosupp : psoriasis
5. Lésions érythémateuses papuleuses arrondies/ovales/annulaires sur le tronc avec collerette desquamative, distribution en sapin de Noël. 1 lésion unique sur le dos précède de quelques jours = le médaillon (car concentration virale élevée au début)
 - **Pityriasis rosé de Gibert** : cause = HHV6 et 7
 - Syphilis
 - Toxidermie : attention à l'anamnèse médicamenteuse
 - LED
 - Primo-infection VIH

6. 15 ans, lésion annulaire prurigineuse faite de microvésicules érythémateuses et squameuse : dermatophytose (DD : granulome annulaire). Quel test ?
- Blankophor
7. Photo + lésions élémentaires = papules sur le visage...
- Toxidermie
 - Eczéma de contact
 - Photodermatose
 - **Zona**
 - Rosacée
8. Erythème en vespertillo ? papillon (LED), examen de la biopsie direct montre :
- Bande linéaire : pemphigoïde bulleuse
 - **Bande granulaire au niveau de la JDE** : infiltrat lichénoïde (= présent à la JDE) inflammatoire qui commence à la JDE et qui descend en profondeur avec la chronicisation. Épaississement de la LB. = bande lupique
 - Marquage intra-épidermique en maille de filet : pemphigus vulgaire
 - Marquage des corps cytoïdes au niveau de la JDE : lichen plan
 - Marquage des vx du derme superficiel : vasculite
9. Tuméfaction érythémateuse de la jambe droite, chaleur, trajet lymphangitique et mycose interdigitale du pied D
- Lymphangite : ne fait pas de tuméfaction érythémateuse
 - **Dermo-hypodermite** infectieuse
 - Périartérite noueuse : plutôt nouures localisées
 - Insuffisance artérielle : ulcération en périphérie
 - Thrombophlébite : sur le trajet veineux, localisé
- NB : possibilité de faire un bilan artério-veineux si doute

10. 24 ans, EF 38.5, pharyngite, céphalées. Diagn de primo-infection VIH.



11. Lésions palmaires maculas non prurigineuses. Prise en charge ?

- TT d'épreuve de courte durée avec crème à la cortisone

- Culture mycologique
- Examen histo
- **Examen sérologique** : syphilis
- Tests épicutanés

DD : VIH, toxidermie, syphilis (les 3 = exanthème maculo-papuleux)

12. 64 ans, nodule sur le nez depuis une année. Prise en charge ?

- Anamnèse
- Palpation du nodule
- Dermatoscopie
- **Biopsie** : pour diagn et ensuite planifier
- Excision avec marge de sécurité de 2cm

DD : tumeur épithéliale, carcinome spino-cell

13. Photo d'un mec tout rouge :

- Eczéma de contact
- Erysipèle
- LED
- Lymphome
- **Rosacée** : rouge car vasodilatation des vx et inflammation (princ lymphocytaire)

14. Tumeur paranasal D qui saigne parfois de façon spontanée

- **Carcinome basocell** : car il y a des vx dans le nodule, histologiquement pallisading et fente de rétraction
- Histiocytofibrome
- Mélanome nodulaire amélanotique
- Carcinome spinocell
- Fibroxanthome atypique

15. Sorte de mélanome entre 6-10mm

- **Excision de la tot de la lésion pour examen histologique** : car > 6mm
- Biopsie pour examen histologique
- Radiothérapie
- Contrôle dans 3 mois
- Aucune des mesures susmentionnées

NB Mélanome malin :

- A extension superficiel (SMM= superficial spreading melanoma)
- Nodulaire
- Acrolentigineux
- Mélanome à lentigo malin (lentigo maligna melanoma) : se dev sur lentigo maligna = Mélanose de Dubreuil (sur les zones photo-exposées)

Facteur pronostic du mélanome : extension en profondeur (= indice de Braslow : mesure à partir de la couche granuleuse de l'épiderme jusqu'à la dernière cell en profondeur du derme, cut-off = 0.8 mm). A savoir question d'exa.